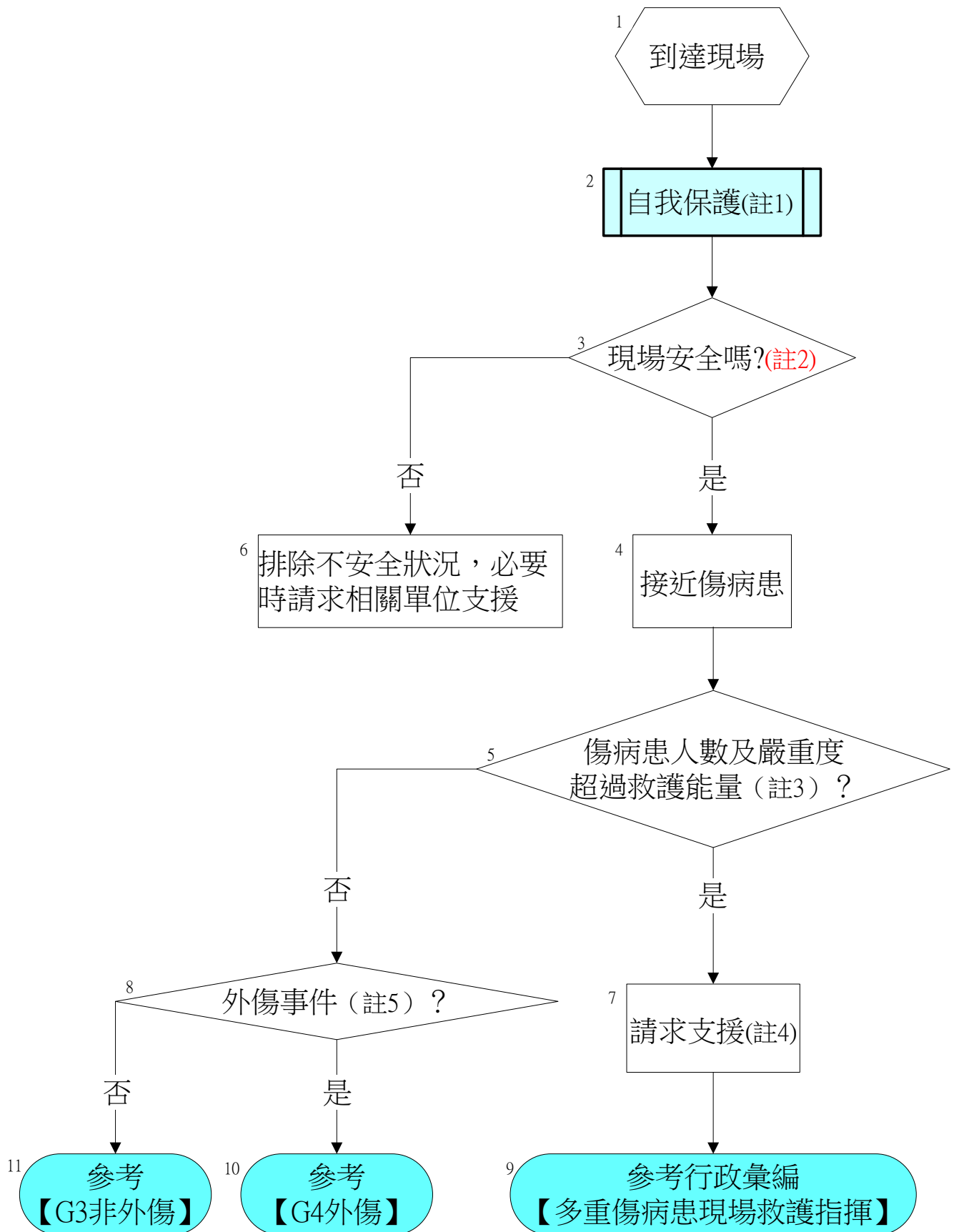


G2 現場評估

程 序



要 旨

- 一、【自我保護】與「現場安全」是所有到院前緊急救護作業程序的第一要務。救護員不應於危及自身安全之狀況下進行救護作業。
- 二、請求支援以傷病患人數及嚴重度超過救護能量為原則，但不以此為限；救護人員若無法掌握現場狀況時，亦可向救災救護指揮中心進行回報並請求支援。
- 三、參考本局行政彙編多重傷病患現場救護指揮程序。

註 解

註1>

- 一、非外傷案件：應確認傷病人及施救人員安全後方可接近病人，若懷疑病人有呼吸道感染（其他傳染疫病）應請病人自行戴上外科口罩，或由家屬、朋友及EMT協助。（病人戴口罩時， EMT應遠離病人顏面部）。
- 二、外傷案件：應優先確認自身安全，除配戴安全帽外可考慮護目鏡及防穿刺手套，並可準備棉被鋪於地面避免穿刺傷。

註2>

- 一、非CBRNE(化學、生物、放射性、核子、爆炸)事件之安全考量。

（一）進入現場前，檢視以下步驟(PAUSE)：

- **P** (Personal Safety)：個人安全、檢視裝備（手套、口罩、背心）。
- **A** (Assess Scene)：評估現場、確認環境（室內、室外、野外…）。
- **U** (Understand Hazards)：理解危害、潛在威脅（氣體、暴力、車流…）。
- **S** (Seek Assistance)：請求支援，回報救指(救災車組、警察、衛生局…）。
- **E** (Exit Plan)：撤退計畫、替代方案(如逃生路動線)。

（二）環境安全與察覺指標

情境類別	關鍵察覺指標 (Indicators)	安全注意事項 (Precautions)
一氧化碳 (CO)	1.群聚症狀：現場多人（及寵物）同時感到頭痛、頭暈、噁心。 2.環境有燻黑痕跡、熱水器裝設室內。 3.通風不良的窒息感。 4.CO 偵測器警報。	1.可見傷病患時緊急搬運至戶外，疏散現場人員至戶外。 2.勿開啟電源開關(如電燈…等)。 3.回報救指中心請求救災車組支援。

情境類別	關鍵察覺指標 (Indicators)	安全注意事項 (Precautions)
有害氣體/毒氣	1.嗅覺與視覺：不尋常的苦杏仁味、漂白水味或刺激性氣味。 2.低處有不明煙霧。 3.傷病患出現呼吸困難或皮膚發紺。	採上風處進入，若懷疑為毒氣，應立即退出並回報救指中心請求救災車組支援(必要時請環境部化學物質管理署支援)。
暴力/家暴現場	1.環境氛圍：物品散亂、破碎。 2.現場人員情緒過於激動或異常安靜。 3.現場有毒品或相關施打用具。	1.回報救指中心確認 110 是否同步通知。 2.現場危險(熱區)，110 未到前確保自身或其他人安全，傷病患有立即危險時，必要時進行止血及緊急搬運至相對安全區域(暖區)。 3.EMT 儘可能在建築物出口處前，確保狀況危急時的逃生路徑順暢(不要讓家屬或傷病患處於 EMT 與出口之間)。
歹徒持刀/槍	1.聲音與視線：現場傳出爭吵、玻璃破碎或槍聲。 2.群眾逃竄方向。 3.觀察或旁人雙手位置（是否插口袋或藏身後）。	1.選擇安全區域待命，善用掩體 (Cover)。 2.疑似槍擊現場時，救護車應停在視線死角外，待警方回報「現場安全」後才進入。
交通事故	1.衍生災害：油品洩漏、電線掉落、未啟動的空氣囊（可能突然彈出）。 2.現場後方車流是否已被有效。	1.於車禍肇事現場上游處擺放三角錐約 30 公尺(40 步幅長)；快(高)速道(公)路交通事故請參閱程序彙編。 2.穿戴高反光背心。進入車內救援前，確保車輛已熄火並固定輪胎。
工地/建築結構	1.垂直威脅：上方是否有懸吊物、結構不穩的牆面。 2.現場粉塵濃度。 3.是否有高壓電纜及掉落之可能。	1.配戴局發頭盔耳罩組(或救護帽) 2.粉塵濃度高時應配戴護目鏡。 3.遵循工安人員引導，避免單獨進入未經加固的地窖或高處。
蛇咬傷	1.觀察草叢深處的沙沙聲、石縫中。 2.如有傷患，觀察其傷口（因毒蛇有毒牙，若有 1-2 處毒牙痕可能是毒蛇咬傷；排狀齒痕比較可能不是毒蛇）。	1.辨識(或詢問傷患)蛇的外觀。 2.確保傷患者遠離咬傷地點（蛇可能還在附近）。

情境類別	關鍵察覺指標 (Indicators)	安全注意事項 (Precautions)
蜂群	1.聲響與群聚：巨大的嗡嗡聲、樹上或地底的蜂巢。 2.傷患身體出現急性過敏反應(聲音沙啞、身體癢、不明原因紅疹)。	1.若仍有蜂群追趕，應迅速帶病患離開該區域（可進入車內或密封室內）。 2.救護人員應觀察周圍是否有「偵察蜂」在現場盤旋不離開。
惡劣地形/天候	1.地質環境：土石鬆動、溪水暴漲、雷擊徵兆（毛髮豎起）。 2.建築物：傾斜的電線桿、斷裂下垂的電線、冒泡的積水、鬆動的招牌、鐵皮、遮雨棚、外牆剝落的磁磚。	1.配戴局發頭盔耳罩組(或救護帽) 2.確保有足夠的照明與保暖設備 3.通訊裝備保持暢通。 4.回報救指中心，請求支援。

二、疑似CBRNE(化學、生物、放射性、核子、爆炸)事件之安全考量

(一) 進入現場前，檢視以下步驟 (RAIN)：

- **R (Recognize)**：識別環境、傷亡線索（不明霧氣、大量動物死亡）。
- **A (Avoid)**：避開物質、上風上坡(避免接觸任何可疑物質，移動至上風、上坡處)。
- **I (Isolate)**：隔離管制、限制傷患(劃定初步管制區，將已暴露傷患限制在特定區域)。
- **N (Notify)**：通報救指、METHANE 傳資(通報救指中心，以 METHANE 方式通報)。

(二) 環境安全與察覺指標

情境類別	關鍵察覺指標 (Indicators)	安全注意事項 (Precautions)
環境異常徵兆	1.不明霧氣：無火源下出現煙霧（如高雄氣爆白煙）。 2.動物大量死亡：動物敏感度高，為「礦坑金絲雀」效應。 3.異常液體：非雨天出現不明液體或油膜。 4.植被枯萎：高濃度化學物質造成植被變色。	1.嗅覺準則：若聞到氣味代表太靠近，應立即撤離。 2.警惕嗅覺疲勞：高濃度硫化氫會麻痺嗅覺，聞不到味道不代表安全。
群體傷亡模式	1.症狀一致性：三人以上在無外傷情況下同時出現相似症狀（如瞳孔縮小、流淚、抽搐）。 2.地理聚集性：傷患集中在特定、侷限的區域。	1.終止暴露：最重要的醫療處置是除汙，第一步即是脫除全身衣物（可移除 80-90% 污染物）。 2.熱區管制：絕對禁止未經除汙之人員進入冷區。

情境類別	關鍵察覺指標 (Indicators)	安全注意事項 (Precautions)
化學 / 神經毒劑	1. 膽鹼激躁 (DUMBELS): 針狀瞳孔、心搏過緩、流涎盜汗。最致命為支氣管漏造成的「乾溺水」。 2. 抗膽鹼/擬交感: 觀察瞳孔放大與皮膚濕度(乾為抗膽鹼, 濕為擬交感)。	1. 預防性醫療: 針對神經毒劑應考慮給予 Atropine 與 Pralidoxime (2-PAM)。 2. 呼吸道維持: 確保呼吸道通暢, 應對支氣管痙攣。
延遲性與隱蔽殺手	1. 低水溶性氣體: 如光氣, 初期刺激低, 但 6-24 小時後引發致命肺水腫。 2. 放射性物質: 髒彈初期如一般爆炸, 需靠偵測儀器; 暴露後數小時內嘔吐為高劑量警訊。	1. 低估風險: 對無即時症狀之病患不可掉以輕心。 2. 早期疏散: 面對不明氣體洩漏, 「擴大管制並儘早疏散」優於現場控制。
二次傷害威脅	二次裝置 (Secondary Devices): 針對救援人員的爆裂物陷阱。	場域搜索: 設立指揮站或傷患集結點前, 務必搜索無人看管的背包或異常車輛。

(三) 標準化通報範本 (METHANE)

- M (Major Incident): 確認重大事故, 啟動大量傷病患機制。
- E (Exact Location): 提供確切地點 (如: 台北車站 M3 出口廣場)。
- T (Type of Incident): 事故類型 (如: 疑似不明氣體攻擊)。
- H (Hazards): 現場危害 (如: 刺鼻異味、二次危害風險)。
- A (Access): 建議救援路徑 (應由上風處接近)。
- N (Number): 傷患人數估計 (區分紅區、綠區)。
- E (Emergency Services): 所需額外支援 (如: 化災處理車、除汙帳、大量 Atropine)。

註3>

一、如到達現場發現須急救處置的傷病患超過2人, 救護人員不足以應付現場狀況時, 應請求支援, 在支援未到前應先實施START (Simple Triage And Rapid Treatment) 檢傷分類(參考「附錄IV-1 START、附錄IV-2 JumpSTART大量傷病患檢傷分類法的流程圖」), 再依病情嚴重度決定處置優先順序。

二、大量傷病患事件處理原則

(一) 第1輛救護車到達之資深 EMT 擔任現場救護官, 指揮後續本局支援車組之報到窗口, 於現場協助檢傷及處置, 不執行後送任務為原則, 直到指揮權轉移為止(資深 EMT 到達後交接)。

- (二) 指揮官應優先劃定車輛集結區及車輛進出動線，儘量將救護車人員與裝備集中，以避免眾多種類救護車造成混亂。
- (三) 動員較現場預估的傷亡數為高的救援能量。
- (四) 注意其他可能的危險（有毒化學物質，倒落的電源線）。事件指揮所（Incident Command Post）、集結待命區（Staging area）應設立於安全區域內。
- (五) 依檢傷分類原則處置，視情況進度次級檢傷。
- (六) 現場有民眾可協助時，EMT 可請協助之民眾進行基本救命術(如 CPR、異物哽塞排除、止血…)

三、現場環境：

- (一) 現場為醫療單位，且醫師在現場處置時，可由醫師進行評估與處置；當醫師之醫囑與本局到院前救護流程不符時，EMT 除持續評估與處置傷病患外，應由 1 名 EMT(或 LEADER)與現場醫師進行適當溝通，或依本局 O1 程序啟動線上醫療指導，且醫師指示之醫療行為應由醫事人員執行，如有踰越本局作業程序部分，應請醫事人員於救護紀錄表簽名並陪同送醫。
- (二) 現場為非醫療單位，第一反應員(如民眾、員警或醫護人員等)協助急救時，注意事項如下：
 - 1、救護同仁於現場接手急救後，可優先肯定民眾良性協助參與緊急救護。
 - 2、儘可能在不影響救護處置流程下，委婉徵詢其基本資料或聯絡方式（如服務單位、姓名及聯絡電話），並以錄音方式或記錄於 EPCR 補述區。
 - 3、第一反應員執行基本救命術違反本局程序時，應適時指導或必要時介入接手。

四、現場已有民眾進行急救時，EMT 應先觀察並表明身分，於適當時機接手急救，並與民眾交接現場狀況。

註 4>

若現場超過或預期超過15名傷病患（或3名以上重大傷病患），應即回報救災救護指揮中心，以便啟動本市應變機制。

註 5>

- 一、外傷之判斷可依據是否有創傷機轉及身上是否有傷口來決定，若仍無法判斷，一律以外傷處理。
- 二、8歲以下或25公斤以下之兒童請參考【S8小兒通用】；新生兒請參考【S7新生兒】。